

Avsändare
ST Bungerfeldt, Johanna
Medicin, akutsjukvård Mölndal
Medicinmottagning
431 80 Mölndal
031-3421000 (Ansvar 19050)

Mottagare
Hönö VC

Akutundersökning : -

Akutsvar : -

Telefon akutsvar :

Önskad undersökning

Fortsatt uppföljning

Personnummer
19 480527-5023

Remissdatum
24-06-17

Namn
BRYNGELSSON, BRITT INGELA

GÄRDESVÄGEN 4
47540 HÖNÖ

Tel. hem : 031-966583
Tel. arbete :
Tel. mobil : 0739-917055

Undersökningsplats

Föregående undersökning

Frågeställning / Anamnes

Hej!

UCG är nu utfört på denna patient 240520 som har långdragna besvär med dyspné, bilaterala lungembolier 230110 och därefter insatt på Xarelto som nu bytts till Eliquis på grund av förmaksflimmer. Inga tecken på UCG till förhöjt PA-tryck och inga tydliga tecken till hjärtsvikt stegrat NT-proBNP kan vara sekundärt till patientens flimmer och dyspné problematik kan både bero på flimmer eller nedsatt kondition. Inga hållpunkter för vidare utredning av kronisk lungembolisering utan patienten står på Eliquis behandling fortsatt. Man kan symtomatiskt testa att behandla patienten med Furix och månad mycket besvär med underbenssvullnad men utifrån UCG svaret ingen indikation för ytterligare sviktbehandling.

Tacksam vidare uppföljning av patientens tryck spänningsbesvär via er enligt tidigare anteckningar och remiss.

Med vänlig hälsning

Johanna Bungerfeldt
Läkare

/ldt

Svar

Handläggare

Undersökningsdatum

Utlåtande

2024-05-20 09:30 **ULTRALJUDSKARDIOGRAFI Hjärtmottagning Mölndal (MED52)**

Läk Axelsson, Ulf

Läk

2024-05-22 10:51 / lenwa15

Dikteringsdatum

2024-05-21 11:23:00

Remiss från

dr Carl Nilsson, Hönö Vårdcentral. Daterad 240416.

dr Anette Stjern, Medicin, SU/M. Daterad 230619.

Se även mottagningsanteckning 231102 Lina Zhang Medmott
SU/M, trombosmottagningen.**Utredningsorsak**Nu närmast kontroll avseende pulmonell hypertension enligt
tidigare planering via UCG.**Vänster kammare, diastole** 55 mm (55-60 mm)**Vänster kammare, septum** 9 mm**Vänster kammare, bakvägg** 8 mm**Vänster kammares EF** 50 % (50-60%)**Slagvolym** 80 ml**Cardiac output** 3,9 liter/min**Vänster förmak** 31 cm²LAVI 67 ml/m²**Aortaklaffring** 21,0 mm**Aorta ascendens** 38 mm**Höger förmak** 24 cm²**Lungvensflöde (S/D)** 1**Vävnadsdoppler E/e-kvot** 10**Mitralläckage** Grad 1/3 (Grad 1-2/3)**Decelerationstid E-våg** 183 millisekund (ms)**E/A-kvot** 2,3**Aortaläckage** Grad 0,5/3**Maximal aortagradiant** 11 mmHg**VTI** 22,0 cm**Tricuspidalläckage** Grad 1/3 Gradient 31 mmHg (Grad 1-2/3)**Höger förmakstryck** 5 mmHg**Höger kammartryck** 36 mmHg**Bedömning** Lätt förstörd vänsterkammare med väsentligen ordinär

ejektionsfraktion. Ingen klar bild av

vänsterkammareförtjockning. Förstörade förmak bilat framför

allt vänster. Höger kammare ter sig inte förstörd. Lindrig till

måttlig mitralisinsufficien. Lindrig till måttlig

tricuspidalisinsufficiens. PA-tryck cirka 36 mmHg, ingen klar

förhöjning här. S-prim >10 cm/sek talande för en ordinär

högerkammarfunktion.

Undersökningen är utförd av BMA Haya Kojak.

Patienten är ej informerad om undersökningsresultatet.

Medicinmottagning M

BRYNGELSSON, BRITT INGELA

GÄRDESVÄGEN 4

47540 HÖNÖ

031-966583 (bostad)

0739-917055 (mobil)

Korrespondens

Kopia till Linda Zhang alternativt handledare
MED-mottagningen SU/M inför planerad kontakt.

Huvuddiagnos

Remissvar till Carl Nilsson, Hönö VC.

Bidiagnos

I340 Mitralisinsufficiens

Atgårdskod

I071 Tricuspidalisinsufficiens

AF021 Doppler ekokardiografi, transtorakal, omfattande